



Efeito do montelucaste na manutenção da remissão em pacientes com colite ulcerativa

Diversos estudos demonstraram que os leucotrienos são importantes na patogênese de doenças inflamatórias como asma, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal (Singh RK, 2013). Considerando o papel dos leucotrienos nas vias inflamatórias e devido ao efeito anti-leucotrienos do montelucaste, o objetivo do presente ensaio clínico foi avaliar o efeito do montelucaste na manutenção da remissão em pacientes com colite ulcerativa (CU) durante a redução gradual de corticosteroides.

MÉTODOS

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. 222 pacientes com CU em remissão com prednisolona e mesalazina.

N= 222 (Idade entre 18-75 anos)

Duração: 22 semanas de tratamento + 8 semanas de acompanhamento.

Grupo intervenção (N=98)	Grupo controle (N=124)
Montelucaste 10 mg 1 x ao dia	Placebo 1x ao dia

Desfecho Primário: Eficácia do tratamento e manutenção da remissão; e período livre de recaída.

Marcadores avaliados:

- Calprotectina fecal: Marcador de inflamação intestinal.
- ESR (VHS): Velocidade de hemossedimentação.
- PCR-us: Proteína C-reativa ultrasensível.
- Escore de Mayo parcial: Avaliação clínica da atividade da doença.

RESULTADOS

Taxa de recaída: 32,6% no grupo montelucaste vs. 61,3% no grupo placebo.

Período livre de recaída: significativamente maior no grupo montelucaste (27,2 semanas vs. 20,8 semanas; $p < 0,001$).

Score de Mayo parcial: menores valores no grupo montelucaste ao longo do estudo.

Biomarcadores inflamatórios: níveis significativamente menores de calprotectina fecal, VHS e PCR-us no grupo montelucaste.

Calprotectina fecal > 200 µg/g: frequência significativamente maior no grupo placebo.

Segurança: Nenhum efeito adverso grave relatado.

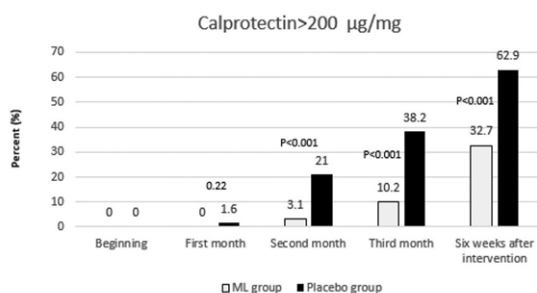


Figura 3. Frequência de pacientes com calprotectina fecal superior a 200 µg/g nos grupos ML e placebo. ML: Montelucaste

CONCLUSÃO

O montelucaste demonstrou efeito protetor significativo na manutenção da remissão em pacientes com CU. É uma opção bem tolerada e pode ser um agente poupador de esteroides.

SHIRAZI, Kourosh Masnadi; DIBA, Mehran Nezam; SHIRAZINEZHAD, Arman Masnadi; NIKNIAZ, Zeinab. Effect of montelukast on remission maintenance in patients with ulcerative colitis: a randomized, double-blind controlled clinical trial. BMC Gastroenterology, v. 25, n. 145, 2025.

FORMULAÇÕES

Montelucaste Apus ExcipSmart LSolv qsp	10 mg 1 cápsula
---	--------------------

Tomar 1 cápsula 1 x ao dia ou conforme orientação médica.

Protocolo do estudo

Período	Duração	Tratamento
Indução	Pré-estudo	Prednisolona 1 mg/kg + Mesalazina 3 g/dia
Redução de esteroides	14 semanas	Redução gradual até descontinuação
Intervenção principal	22 semanas	Montelucaste 10 mg/dia ou placebo
Acompanhamento pós-intervenção	8 semanas	Sem medicação (montelucaste / placebo ou esteroides)

Tofacitinibe oral

Eficácia e segurança no tratamento da colite ulcerativa

Um estudo de centro único, duplo-cego e controlado por placebo, avaliou a adição de tofacitinibe aos corticoides na melhora da responsividade ao tratamento em pacientes com colite ulcerativa aguda grave. (SINGH, Arshdeep et al., 2024). De acordo com os resultados a combinação de tofacitinibe e corticosteroides melhorou a responsividade ao tratamento e diminuiu a necessidade de terapia de resgate.

Tofacitinibe Apus ExcipSmart Solv qsp	10 mg 1 cápsula
--	--------------------

Administrar 1 cápsula 3 vezes ao dia, após 7 dias administrar 1 cápsula 2 vezes a dia ou conforme orientação médica

SINGH, Arshdeep et al. Tofacitinib in acute severe ulcerative colitis (TACOS): a randomized controlled trial. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG, v. 119, n. 7, p. 1365-1372, 2024..



apusnutricosmeticos

SUA LOGO AQUI